Tipo do Documento	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**	Página 1/6	
Título do Documento	**CIRURGIA SEGURA**	Emissão: 01/08/2026 Versão: 2	Próxima revisão: 01/08/2028

1. CONCEITO: A segurança cirúrgica consiste numa "sequência de etapas necessárias na assistência, não apenas pelo cirurgião, mas pela equipe de profissionais de assistênc

1.1 Responsável pela prescrição

Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra

1.2 Responsáveis pela execução

É de responsabilidade de todos os profissionais da assistência, seja cirúrgica ou clínica, que encaminham os pacientes.

1.3 Finalidades

• Atender a meta internacional de Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos respaldada pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente.

• Prevenir a ocorrência de erros decorrentes de procedimentos cirúrgicos dos pacientes em período perioperatório, em todos os setores do Hospital São Vicente de Paulo. Visando, desta forma, a redução das ocorrências de incidentes, eventos adversos e a mortalidade cirúrgica.

1.5 Contraindicações/Restrições

Não há

2. MATERIAIS

- Check list de cirurgia (Via sistema SOUL)
- Computador;
- Quadro de TIME OUT em salas operatórias;

3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

Período Pré-operatório

Aplicação do Checklist de cirurgia segura

a) Identificação correta do paciente:

• Todo paciente deverá portar de pulseira de identificação de cor branca, contendo os dados: Instituição, nome completo, data de nascimento, nº do prontuário e código de barras;

• O prontuário do paciente deverá conter informações de identificação, assim como exames atuais que comprovam o tipo de cirurgia a ser realizado;

• A confirmação dos dados de identificação deverá ser feita em todo o período perioperatório.

b) Conscientização do paciente sobre o procedimento:

• Todo o paciente tem direito de receber orientações sobre o procedimento cirúrgico e cuidados necessários no período perioperatório, desde o ambulatório até o momento de entrada no centro cirúrgico;

• É necessário oferecer apoio emocional e psicológico ao paciente no período perioperatório.

c) Confirmação do sítio cirúrgico e da cirurgia realizada:

• Conferir com o prontuário, história do paciente e mapa cirúrgico a cirurgia a ser realizada, bem como a confirmação do sítio cirúrgico;

• Planejar cuidados específicos de enfermagem de preparação para o procedimento cirúrgico

d) Avaliação anestésica e medicações a serem administradas:

• Checar a avaliação realizada com anestesista, medicamentos a serem administrados, bem como a presença da ficha de anestesia no prontuário;

• Rever a existência de alergias, comorbidades e estado geral do paciente através da coleta de dados inicial no histórico de enfermagem e ficha de anestesia;

• Checar a existência de identificação de riscos para o paciente.

e) Presença dos exames pré-operatórios e prontuário completo:

• Conferência do prontuário, garantindo a integridade das informações;

• Incluir os exames solicitados atualizados.

f) Método de anotação no prontuário do paciente:

• Histórico e prescrição de enfermagem, baseado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta, elaborados pelo enfermeiro da unidade de internação;

• Preencher o chek-list de cuidados pré-operatórios pela equipe de enfermagem, conferido e assinado pelo enfermeiro;

• Folha de avaliação anestésica, preenchida pelo anestesista.

• História clínica, anamnese e prescrição, preenchido pela equipe médica de cirurgia.

Período Trans-operatório ou intervenção cirúrgica

a) Antes da indução anestésica:

• Confirmar com o paciente: Identificação do paciente; Lado a ser operado; Operação a que vai ser submetido; Consentimento esclarecido para cirurgia e anestesia.

• Sítio assinalado (se necessário): Confirmar o sítio cirúrgico correto e sua demarcação.

• Conexão de monitor: Confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e seu funcionamento;

• Oximetria de Pulso Funcionando: Monitorização adequada do paciente

• Revisar com anestesista: Alergias e uso de clampe vermelho em pulseira de identificação; Dificuldade respiratória, em caso de risco de aspiração, possui aspirador disponível;

b) Antes da incisão:

• Todos os membros se apresentam: Nome e função

• Cirurgião, Anestesista e Enfermagem confirmam verbalmente: Paciente; Lado; Procedimento;

• Antimicrobianos profiláticos: administração nos últimos 60 minutos da incisão cirúrgica.

c) Antecipação Eventos Críticos:

• Cirurgião: Quais os tempos críticos e eventos inesperados; Duração da operação; Possibilidade de sangramento.

• Anestesista: Quais as preocupações especiais do caso.

• Enfermagem: A indicação da esterilização está correta; Os equipamentos necessários estão presentes e funcionantes; O antibiótico profilático foi administrado nos últimos 60 minutos; Disponibilidade das imagens necessárias ao procedimento para os profissionais.

d) Antes do paciente deixar Sala Operatória:

• Tipo de procedimento registrado e relatório de cirurgia realizado;

• Instrumentos, compressas, gases e agulhas foram contadas;

• Paciente e peças devidamente identificados;

• Registro e revisão de qualquer funcionamento inadequado com algum equipamento;

• Revisão do plano de cuidado e providências quanto à abordagem operatória e recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala de cirurgia.

4. INTERVENÇÕES/OBSERVAÇÕES

1. **Confirmar avaliação pré-anestésica e condições clínicas para o procedimento**, conforme protocolo institucional.
2. **Verificar jejum, preparo pré-operatório e exames necessários**, de acordo com o procedimento e condição clínica.
3. **Verificar a disponibilidade de sangue/hemoderivados**, quando houver risco de sangramento significativo.
4. **Confirmar a antibioticoprofilaxia**, quando indicada, observando medicamento, dose, alergias e horário de administração conforme protocolo institucional.
5. **Realizar o "Time Out" imediatamente antes da incisão**, interrompendo as demais atividades para que a equipe confirme verbalmente:

- paciente;
- procedimento;
- sítio/lateralidade;
- posicionamento;
- antibioticoprofilaxia;
- riscos críticos;
- equipamentos e materiais;
- necessidade de exames de imagem;
- eventos ou condições especiais.

1. **Não iniciar a cirurgia diante de divergências ou dúvidas relacionadas à identificação, procedimento ou sítio cirúrgico**, até que a situação seja esclarecida.
2. **Realizar contagem de compressas, gazes, agulhas e instrumentais**, conforme rotina institucional, especialmente antes do fechamento da cavidade e ao término do procedimento.
3. **Realizar conferência e identificação adequada das peças cirúrgicas**, contendo as informações necessárias antes do encaminhamento ao laboratório.
4. **Realizar o "Sign Out" antes da saída do paciente da sala cirúrgica**, confirmando:

- procedimento realizado;
- contagem de instrumentais, compressas e agulhas;
- identificação das peças;
- problemas relacionados a equipamentos;
- cuidados e recomendações para recuperação pós-operatória.

1. **Garantir comunicação estruturada entre a equipe cirúrgica, anestésica e unidade de destino**, especialmente quanto a riscos, intercorrências e cuidados necessários.
2. **Registrar o preenchimento do Checklist de Cirurgia Segura** no prontuário ou sistema institucional.
3. **Notificar incidentes, quase falhas e eventos adversos** identificados durante o processo cirúrgico, conforme fluxo institucional de gerenciamento de riscos.
4. **Realizar intervenção imediata diante de qualquer condição insegura**, podendo incluir a suspensão ou adiamento do procedimento até que o risco seja controlado.

Intervenções para prevenção de queimaduras por bisturi elétrico

1. Antes do procedimento

- Confirmar indicação e necessidade do uso do bisturi elétrico.
- Verificar **integridade, funcionamento e condições de conservação** do equipamento, cabos, caneta/eletrodo ativo, placa dispersiva e acessórios.
- Conferir se o equipamento está conectado corretamente e realizar teste funcional conforme orientação do fabricante e rotina institucional.
- Avaliar o paciente quanto à presença de:
    - marcapasso ou cardiodesfibrilador implantável;
    - próteses metálicas;
    - adornos e objetos metálicos;
    - alterações de pele, feridas, cicatrizes ou lesões no local previsto para a placa.
- Retirar adornos metálicos e outros materiais condutores desnecessários.
- Garantir que o paciente esteja **seco**, evitando contato da pele com soluções antissépticas acumuladas.
- Posicionar o paciente de forma a evitar contato direto da pele com superfícies metálicas da mesa cirúrgica.
- Selecionar o **local adequado para posicionamento da placa dispersiva**, considerando o tipo de procedimento e as orientações do fabricante.
- Preferir área de pele íntegra, seca, bem vascularizada e com adequada massa muscular.
- Evitar posicionar a placa sobre:
    - proeminências ósseas;
    - cicatrizes;
    - áreas com pelos excessivos, quando comprometerem a adesão;
    - tecido adiposo excessivo;
    - pele lesionada, edemaciada ou com alteração de sensibilidade;
    - implantes metálicos ou próteses, quando houver alternativa segura.
- Não cortar, dobrar ou modificar a placa dispersiva.
- Garantir **contato completo da placa com a pele**, sem presença de rugas, bolhas ou descolamento.
- Evitar que cabos e eletrodos fiquem sob o paciente ou em contato com superfícies metálicas.
- Quando houver utilização de soluções inflamáveis, assegurar **secagem completa da pele** antes da ativação do bisturi elétrico.

2. Durante o procedimento

- Manter a placa dispersiva aderida à pele durante todo o procedimento.
- Evitar reposicionamento ou manipulação da placa após o início da cirurgia, salvo necessidade identificada pela equipe.
- Utilizar a **menor potência eficaz** para a realização do procedimento, conforme avaliação do cirurgião e características do equipamento.
- Evitar acionamentos prolongados e desnecessários do bisturi elétrico.
- Manter a ponta ativa do eletrodo em local seguro quando não estiver em uso.
- Nunca deixar a caneta de bisturi elétrico sobre o paciente, campos cirúrgicos ou superfícies que possam entrar em contato inadvertidamente com o eletrodo.
- Evitar contato simultâneo do eletrodo ativo com instrumentos metálicos que possam conduzir corrente para outras regiões do paciente.
- Manter atenção para acúmulo de soluções alcoólicas ou outros líquidos sob o paciente.
- Suspender imediatamente o uso do equipamento diante de:
    - cheiro de queimado;
    - fumaça inesperada;

- faíscas;
- funcionamento irregular;
- alarmes do equipamento;
- aquecimento anormal;
- suspeita de queimadura.

- Comunicar imediatamente ao cirurgião e ao enfermeiro responsável qualquer intercorrência relacionada à eletrocirurgia.

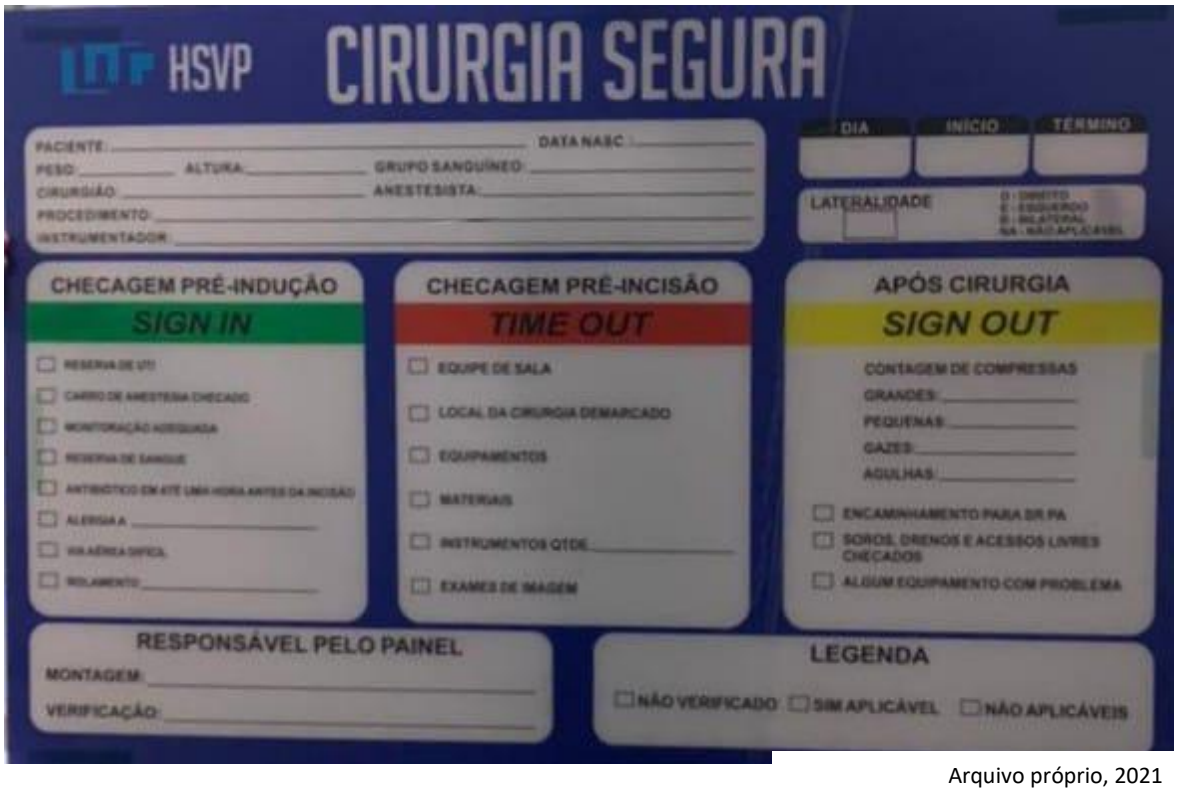
3. Após o procedimento

- Desligar o equipamento e desconectá-lo conforme orientação do fabricante.
- Retirar cuidadosamente a placa dispersiva, evitando lesionar a pele.
- **Inspecionar a pele no local da placa**, observando hiperemia, dor, bolhas, lesões ou alteração de coloração.
- Avaliar também áreas que possam ter sofrido contato inadvertido com partes metálicas ou líquidos.
- Registrar no prontuário:

  - utilização do bisturi elétrico;
  - local de posicionamento da placa;
  - condições da pele após sua retirada;
  - intercorrências, quando presentes.

- Em caso de suspeita ou identificação de queimadura, comunicar imediatamente o responsável, realizar avaliação da lesão e seguir o **protocolo institucional de manejo e notificação de eventos adversos**.
- Registrar e notificar o evento conforme fluxo institucional de Segurança do Paciente.

5. ILUSTRAÇÕES / ANEXOS



Arquivo próprio, 2021

6. REFERÊNCIAS

Azevedo, D. K. L., da Silva, C. M. P., & Maia, A. L. (2021). O papel da gestão de enfermagem na implementação da meta de cirurgia segura: uma revisão de literatura. *Research, Society and Development*, *10*(14), e584101422711-e584101422711. Disponivel em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22711

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Nacional de Segurança do Paciente: protocolo para cirurgia segura. PROQUALIS. Maio de 2013. Acesso 06/2023. Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2013/Mai/06/protocolos_CP_n6_2013.pd f OMS.

Organização Mundial da Saúde - OMS (World Health Organization). Desafio global para a segurança do paciente. Manual - Cirurgias salvam vidas. Rio de Janeiro: Organização PanAmericana de Saúde; Ministério da Saúde; Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2010.

THE JOINT COMMISSION. *Sentinel Event Alert 68: updating surgical fire prevention for the 21st century*. Oakbrook Terrace, IL: The Joint Commission, 2023. Disponível em: . Acesso em: 5 out. 2026.

7. HISTORICO DE ELABORAÇAO/REVISAO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	01/08/2023	Atualização e padronização
2	01/07/2025	Atualização
3	01/08/2026	Atualização

Versão 1 - Elaboração Nayanne Ingrid Farias Mota Guerra	Data: 01/07/2025
Revisão Giulianna Carla **Validação** Claudio Emmanuel **Registro, análise e revisão final** Giulianna Carla Claudio Emmanuel **Aprovação** Claudio Emmanuel Sonia Delgado	Data: 01/08/2026